



**"ООО" НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КЛИНИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ**

Санкт-Петербург, проспект Славы, дом 32, литера А
телефон: 8-812-679-42-50; Почта: registr@ncmd.ru
Лицензия № Л041-01148-78/00333528

ПРОТОКОЛ

**Гистологического исследования биопсийного (операционного) материала
Регистрационный № 144201**

Фамилия, имя, отчество (при наличии) пациента: **Ковалев Андрей Николаевич**

Пол: **мужской**

Дата рождения: **17.04.1983**

№ Карты: **104720**

Возраст: **42**

Место регистрации:

Телефон:

Медицинское учреждение/отделение/врач,
направившее биопсийный (операционный) материал

АРМЕД ООО
Мороз Ю.Ю.

Диагноз заболевания (состояния) по данным направления: Эрозивно-язвенный илеит. Признаки очагового катарального колита.

Код МКБ по данным направления: K63.9

Дата забора материала по данным направления: 20.10.2025

Материал помещен в 10%-ный раствор нейтрального формалина: да

Материал загрязнен: нет

Дата поступления материала: 27.10.2025 16:26

Отметка о сохранности упаковки: да

Дата регистрации материала: 27.10.2025 16:26

Вырезка проводилась: 27.10.2025 16:26

Маркировка материала: 4 кус из слизистой оболочки подвздошной кишки; 1 кус из слизистой оболочки слепой кишки; 3 кус из слизистой оболочки восходящей ободочной кишки; 1 кус из слизистой оболочки поперечной ободочной кишки; 1 кус из слизистой оболочки нисходящей ободочной кишки; 2 кус из слизистой оболочки сигмовидной кишки; 2 кус из слизистой оболочки прямой кишки.

Характер материала: биопсия диагностическая

МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 1. 4 биоптата дм по 0,1-0,2 см.

2,4,5. По 1 биоптату дм по 0,2 см.

3. 3 биоптата дм по 0,1-0,2 см.

6,7. По 2 биоптата дм по 0,1-0,2 см.

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 1) Фрагменты слизистой оболочки подвздошной кишки с эрозированием, изъязвлением, фокальным умеренным воспалительным компонентом, очаговой умеренной активностью, участками нарушения гистоархитектоники в виде расширения и укорочения ворсинок, очаговой толстокишечной метаплазией, без признаков нозологической принадлежности.

2-7) Фрагменты слизистой оболочки толстой кишки со слабым субэпителиальным воспалительным компонентом, без активности, с участками поверхностного эпителия регенераторного типа, очаговой лимфофолликулярной гиперплазией, очаговой зубчатой трансформацией желез (биоптат №6), без нарушения гистоархитектоники собственной пластинки слизистой оболочки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1) Хронический сегментарный эрозивно-язвенный илеит с фокальным умеренным воспалительным компонентом, очаговой умеренной активностью, участками нарушения гистоархитектоники в виде расширения и укорочения ворсинок, очаговой толстокишечной метаплазией, без признаков нозологической принадлежности.

2-7) Поверхностный колит со слабым субэпителиальным воспалительным компонентом, без активности, с участками поверхностного эпителия регенераторного типа, очаговой лимфофолликулярной гиперплазией, очаговой зубчатой трансформацией желез (биоптат №6), без нарушения гистоархитектоники собственной пластинки слизистой оболочки.

С учетом сегментарного характера поражения, гистологическая картина наиболее характерна для болезни Крона с поражением терминального отдела подвздошной кишки.

Код МКБ: K50.9

Выполнил: 30.10.25 19:29. Горшков Илья
Андреевич.



Сериков